

Facteurs pronostiques du mélanome malin de l'uvée

Étude rétrospective sur 2 241 patients et apport récent de la recherche de la monosomie 3

L. Desjardins, C. Levy-Gabriel, L. Lumbroso-Lerouic, X. Sastre, R. Dendale, J. Couturier, S. Piperno-Neumann, T. Dorval, P. Mariani, R. Salmon, C. Plancher, B. Asselain

Institut Curie, Paris.

Correspondance : L. Desjardins, Service d'Oncologie Oculaire, Institut Curie, 26, rue d'Ulm 75005 Paris.

Reçu le 5 décembre 2005. Accepté le 7 avril 2006.

Prognostic factors for malignant uveal melanoma. Retrospective study on 2,241 patients and recent contribution of monosomy-3 research

INTRODUCTION

L. Desjardins, C. Levy-Gabriel, L. Lumbroso-Lerouic, X. Sastre, R. Dendale, J. Couturier, S. Piperno-Neumann, T. Dorval, P. Mariani, R. Salmon, C. Plancher, B. Asselain

J. Fr. Ophtalmol., 2006; 29, 7: 741-749

Introduction: We conducted a retrospective study on the clinical factors influencing the local and general prognosis of patients treated for uveal melanoma with a preliminary analysis of the prognostic value of monosomy 3.

Patients and method: The patients sent to Curie Institute for uveal melanoma have a complete initial clinical evaluation, conservative management by radiotherapy or enucleation, and local and general long-term follow-up. Over the last 5 years, the status of chromosome 3 has been assessed by FISH in the tumors of enucleated patients. Findings concerning the initial workup, treatment, and follow-up are recorded prospectively. We conducted a retrospective study with multivariate analysis of the clinical factors influencing local recurrence, ocular conservation metastasis, and survival and studied the effect of monosomy 3.

Results: A total of 2241 patients were registered with a median follow-up of 72 months. Of these patients, 92.8% had conservative management with iodine 125 brachytherapy or proton beam therapy and 7.2% of the patients had enucleation ($n=160$). Tumors from 120 patients were studied for the status of chromosome 3 by FISH. The overall survival rate was 76.3% and the metastatic rate was 19.5%. The clinical factors influencing survival were the size and location of the tumor, age of the patient, gender, and initial treatment. The factors influencing the metastatic risk were the same plus retinal detachment and local recurrence. Monosomy 3 was a significant risk factor for metastatic disease.

Discussion: This study found the usual risk factors with the difference that location on the equator seems to be of worse prognosis than ciliary body involvement for survival and metastasis. In addition, the initial retinal detachment appears to be a risk factor for local recurrence and metastasis. At present, the evaluation of chromosome 3 is available for enucleated tumors but it could probably be done on needle biopsy performed during conservative management as well.

Conclusion: This study confirms previous results on the prognostic factors of uveal melanoma and on the value of monosomy 3. The increasingly precise identification of a group of high-risk patients should allow us to propose adjuvant therapy and to adapt follow-up.

Key-words: Uveal melanoma, prognostic factors, retinal detachment, monosomy 3.

Depuis quelques années, les facteurs pronostiques du mélanome malin de l'uvée ont été enrichis par les données des études cytogénétiques de la tumeur démontrant la valeur pronostique péjorative de l'existence d'une monosomie 3 [1]. Les facteurs pronostiques essentiels connus depuis de nombreuses années sont la taille et la localisation de la tumeur, le type histologique et l'aspect de la vascularisation tumorale, l'âge du patient et l'existence d'une extériorisation de la tumeur [2, 3].

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur les patients pris en charge à l'institut Curie et notamment les patients dont la tumeur présentait une monosomie 3. Nous avons inclus dans l'étude les patients traités entre juillet 1985 et juin 2002, en excluant cependant les patients traités par disque de cobalt, ce traitement n'étant plus utilisé actuellement.

PATIENTS ET MÉTHODE

Le bilan initial

Les patients adressés à l'institut Curie pour le traitement d'un mélanome choroïdien ont un bilan initial standard comprenant une acuité visuelle, un examen à la lampe à fente, une

Facteurs pronostiques du mélanome malin de l'uvée. Étude rétrospective sur 2 241 patients et apport récent de la recherche de la monosomie 3

Introduction : Nous avons réalisé une étude rétrospective des facteurs cliniques influençant le pronostic local et général chez des patients atteints de mélanome choroïdien. Nous avons effectué une analyse préliminaire de la valeur pronostique de la monosomie 3.

Patients et méthode : Les patients adressés à l'Institut Curie pour un mélanome de l'uvée ont un bilan initial complet, un traitement conservateur radiothérapique ou une énucléation